Caso clínico: Infecção do trato urinário associada ao cateter vesical de demora (ITU-AC) em paciente internado por Acidente Vascular Cerebral (AVC)

● **Entenda o caso**: J. C. A., sexo masculino, 68 anos, internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após episódio de AVC isquêmico, apresentando redução do nível de consciência e mobilidade prejudicada. Devido à necessidade de monitoramento rigoroso do débito urinário, foi realizada a inserção de Cateter Vesical de Demora (CVD) no 1° dia de internação, utilizando-se técnica asséptica. O paciente permaneceu com o dispositivo por seis dias consecutivos. Então, no 6° dia de internação, apresentou febre de 38,7 °C, calafrios, taquicardia (108 bpm) e desconforto à palpação da região suprapúbica. Adicionalmente, verificou-se frequência respiratória de 22 irpm, pressão arterial 115x72mmHg, saturação de oxigênio (SpO_2) 96%. A equipe de enfermagem também identificou que a urina estava com aspecto turvo na bolsa coletora.

● **Diagnóstico**: Diante das manifestações clínicas, foi levantada a suspeita de infecção do trato urinário associada ao cateter vesical de demora (ITU-AC), sendo solicitada avaliação médica e investigação laboratorial. Com isso, foram obtidos os seguintes dados:

• Leucocitose (15.300 leucócitos/mm^3)
• Neutrofilia (Neutrófilos 88%)
• Proteína C Reativa – PCR elevada (86 mg/L)
• Ureia (42 mg/dL) e Creatinina (1,1mg/dL) sem elevação significativa ao basal
• Urocultura com crescimento bacteriano significativo (100.000 UFC/mL de *Escherichia coli*)

A associação entre febre, desconforto suprapúbico, leucocitose e urocultura positiva para *E. coli*, contagem microbiana igual ou superior a 10^5 UFC/mL, reforça a suspeita de ITU associada ao cateter, pois os dados apresentados são compatíveis com os critérios diagnósticos e epidemiológicos de ITU-AC em adultos, segundo as diretrizes da ANVISA.

● **Abordagem assistencial:** diante da detecção do quadro infeccioso, e considerando o contexto do AVC, o cuidado iniciou-se por meio de um conjunto de medidas práticas:

• Avaliação clínica contínua, ao monitorar temperatura, frequência cardíaca, pressão arterial, frequência respiratória, nível de consciência, débito urinário e sinais de possível evolução para sepse;

• Investigação laboratorial, onde foi realizada a urocultura com antibiograma, antes do início da antibioticoterapia. Destacando-se que, essa coleta ocorreu de modo asséptico pelo dispositivo próprio de amostragem do sistema, e não diretamente da bolsa coletora (essa ação não deve ser feita pois, a urina que fica acumulada na bolsa já está ali há algum tempo, em contato com bactérias que possam ter se multiplicado dentro do reservatório. Isso gera um resultado falso positivo ou distorce a verdadeira condição do paciente. Somado a isso, abrir ou manipular a bolsa coletora para retirar o líquido aumenta consideravelmente o risco de introduzir microorganismos que sobem pelo sistema e causam uma ITU).

• O tratamento medicamentoso foi iniciado brevemente, no qual a antibioticoterapia prescrita pelo médico (Levofloxacino 500mg 24/24h via endovenosa) foi escolhida considerando o quadro clínico neurológico e geral, a gravidade da infecção, a função renal, o perfil de resistência bacteriana e o resultado da urocultura e do antibiograma;

• Manutenção do foco na prevenção de novas infecções como foco do cuidado, reforçando a higienização das mãos, a manutenção do sistema de drenagem fechado de modo que evitasse desconexões desnecessárias, e mantivesse a bolsa coletora abaixo do nível da bexiga, além de garantir o fluxo urinário livre, sem dobras ou obstruções.

• A equipe estabeleceu também, a avaliação diária quanto ao cateter para verificar a necessidade de permanência do dispositivo. Pois, à medida que não houve mais a indicação clínica, providenciaram sua retirada. Nesses casos, a eventual substituição deve sempre ser avaliada pela equipe assistencial conforme as condições do paciente e o protocolo institucional;

● **Evolução do quadro clínico**: Após avaliação médica, coleta da urocultura e análise do antibiograma, foi iniciada antibioticoterapia (Levofloxacino 500mg 24/24h via endovenosa) programada para o prazo de sete dias. A equipe manteve monitoramento dos sinais vitais, função renal, débito urinário e resposta ao tratamento. A partir disso, o paciente apresentou redução da febre e melhora do desconforto suprapúbico, evoluindo com estabilidade clínica.

● **Discussão geral do caso clínico**: a ITU-AC é uma das infecções mais prevalentes no contexto hospitalar, com quantitativo de casos crescente e preocupante, uma vez que se trata de uma infecção que pode ocasionar complicações, prolongamento da internação, aumento dos custos hospitalares e, em situações mais graves, evolução para sepse.

Particularmente, o caso apresentado revela um alerta importante: a necessidade de compreender que a patologia que motivou a internação, não deve ser o único foco do cuidado, pois outras alterações significativas podem surgir durante a internação clínica e agravar as disfunções prévias. Nessa perspectiva, cabe advertir que as sequelas do AVC, como redução da mobilidade, alteração do nível de consciência e possível comprometimento da função vesical, podem aumentar o grau de dependência do paciente, aumentar o tempo de hospitalização e favorecer a necessidade de dispositivos invasivos, como o cateter vesical de demora. Entretanto, a ocorrência da ITU não é inevitável, e sim prevenível.

● **Cuidados fundamentais**: o caso apresentado demonstra a importância da identificação precoce dos sinais clínicos, da investigação laboratorial adequada e da adoção de medidas preventivas pela equipe multiprofissional, considerando que a detecção das alterações clínicas e a comunicação imediata de possíveis sinais de infecção, podem reduzir a possibilidade de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) e complicações associadas que podem acarretar inclusive o óbito, por causas primárias e/ou secundárias.

Em suma, é válido ressaltar que deve haver uma concentração de esforços da equipe de saúde em desenvolver o trabalho assistencial neurológico e funcional, sem distanciar a possibilidade de surgimento de um processo infeccioso. Sobretudo, há uma necessidade iminente de difundir o conhecimento preventivo quanto à IRAS, ao passo que a prevenção da ITU-AC por exemplo, depende da aplicabilidade da técnica correta de inserção do cateter vesical, mas também da qualidade dos cuidados prestados durante todo o período de utilização do dispositivo.

● **Referências bibliográficas consultadas**:

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. **Nota técnica GVIMS/GGTES nº 03/2026: critérios diagnósticos das infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS)**.

Brasília, DF: ANVISA, 2026. Versão republicada em 14 de julho de 2026. Disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/notas-tecnicas/notas-tecnicas-vigentes/nota-tecnica-03-2026-criterios-de-iras-02-01-2026.pdf. Acesso em: 29 out. 2026.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. **Protocolo para a Prevenção de Infecção do Trato Urinário Relacionada ao Uso de Cateter Vesical de Demora (ITU-AC)**. Brasília, DF: ANVISA. Versão 1, 2025. Publicado em 28 de janeiro de 2026. Disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/servicosdesaude/prevencao-e-controle-de-infeccao-e-resistencia-microbiana/prevencao-das-principais-iras/infeccao-do-trato-urinario/protocolo-3-prevencao-de-itu-final.pdf?utm_. Acesso em: 29 out. 2026.